LE LIVRET DU MÉDICAMENT DU MCS

Adulte et pédiatrique



Un travail de la
Commission Paramédicale Urg'Ara
En collaboration avec le réseau MCS

Version 2.0
Juillet 2026

PRÉFACE

Ce livret est une version simplifiée du livret du médicament Urg'Ara. Il est destiné aux médecins correspondant SAMU (MCS) et aux formateurs des CESU qui assurent l'enseignement annuel des MCS.

Le livret du médicament du réseau régional de médecine d'urgence Urg'Ara est un projet porté par sa Commission Paramédicale et soutenu par des pharmaciens et médecins de la région.
Les Drs Stéphanie FEY DOSDA (Urg'Ara) et JF FAGE ainsi que Dr Agathe MORIN-NOEL, pharmacienne (CHUGA) ont ensuite adapté ce livret au plus près de la dotation et de la pratique des médecins correspondants SAMU.
L'ensemble du travail a été validé par le réseau MCS ainsi que par la commission scientifique du réseau Urg'Ara.

Ce livret a pour objectif principal : **sécuriser l'administration des médicaments injectables les plus courants**, utilisés en médecine d'urgence dans les conditions du médecin correspondant SAMU. Il prévoit l'harmonisation de la prescription (entre urgentiste et MCS), de la préparation et de l'administration du médicament. Il complète également les référentiels de prise en charge Urg'Ara.

Ce livret est à disposition des MCS et des formateurs CESU de la région Auvergne Rhône-Alpes. La version numérique, disponible sur le site internet et l'application Urg'Ara reste la version toujours à jour.

Urg'Ara tient à remercier chaleureusement l'ensemble des professionnels qui ont participé à ce projet.

Ce livret est une aide aux médecins MCS cependant :

- Le médecin pose les indications selon la situation clinique et le profil du patient
- Le médecin reste responsable de sa propre prescription
- Le MCS est responsable de la préparation et de l'administration du médicament
- Il convient de vérifier lors du transfert des patients, la concordance des produits, leur concentration et leur mode d'administration selon la règle des 5B et 10B (Cf. fiche p.13)
- Ce travail est évolutif en fonction des dernières recommandations scientifiques et référentiels d'Urg'Ara. Ainsi, la version numérique sera toujours la version faisant foi et la plus à jour
- Ce livret n'est pas opposable et malgré toute l'attention portée, des « coquilles » peuvent persister. Merci de nous les remonter le cas échéant : urgara@urgences-ara.fr

Urg'Ara met ce livret à disposition des MCS pour un usage personnel dans le cadre du soin.

Ce livret est la propriété intellectuelle d'Urg'Ara, il est protégé par le droit d'auteur.

Aucune partie de ce livret ne peut être reproduite ou utilisée pour un autre usage sans l'autorisation d'Urg'Ara (urgara@urgences-ara.fr). Toute reproduction pour un usage commercial est strictement interdite.

© Copyright 2025 Urg'Ara – Tous droits réservés

RÉDACTION

RÉDACTION et COORDINATION :

- **Urg'Ara : Dr Stéphanie FEY DOSDA**
- **Réseau MCS : Dr Jean François FAGE, Dr Agathe MORIN-NOEL**

- **Mise en page :** Mr Jonas COURTOIS (Urg'Ara), Mme Alexandra VERDUCI (MCS)

- **Commission Paramédicale Urg'Ara**

01 : CH de Fleyriat : Mr Antonin LASSALLE, Mme Virginie PETITJEAN, Mme Angèle VITTE
Hôpital Privé d'Ambérieu : Mme Amandine CARLIER
CH du Haut Bugey : Mme Mathilde NEVES
03 : CH Jacques LACARIN : Mme Nathalie GONNIN
07 : CH Ardèche Nord : Mme Amandine DEL-AGUILA, Mme Florence PINET
CH de Privas Ardèche : Mr Dimitri ARLAUD
15 : CH Henri MONDOR : Mme Marie Anaïs BUSSY
26 : CH Valence : Mme Charlène FAURITE, Mme Delphine HORTEUR, Mme Florence MAISONNEUVE
GH Portes de Provence : Mme Séverine PIQUARD
38 : CHU Grenoble Alpes : Mr Olivier GIROUD
GH Nord Dauphiné : Mme Catherine JACQUIER
42 : CHU Saint Etienne : Mr Mathieu GUILLAUME
CH Le Corbusier : Mme Carolane CAPONY
63 : CHU Clermont Ferrand : Mr Pierre FOURVEL
CH Paul ARDIER : Mme Amélie THOLLET
CH de Thiers : Mme Géraldine AUSSANNAIRE, Mme Sybile DONNA FAYET
CH de Riom : Mr Jonathan CHOLLAT, Mme Lisa GENDRE
69: HCL (GH Sud) : Mme Cindy HERNANDEZ
HCL (GH Nord) : Mme Pauline LIEBY
Urg'Ara : Mme Estelle RIFFE
73 : CH Métropole Savoie (Chambéry) : Mr Martin BOURRIER, Mr Nicolas GILSON
CH Métropole Savoie (Aix Les Bains) : Mme Laura CHARVIER
CH Albertville Moutiers : Mme Sylvie LEVEQUE, Mme Carole PIASCO
CH Vallée de la Maurienne : Mme Morgane LEFEVRE, Mme Marion VERGNEAULT
74 : CH Annecy Genevois : Mme Céline MOREL, Mme Elise POILVE, Mme Emilie WATTELIER
CH Alpes Léman : Mr Alexandre STURMA

Avec la participation du groupe du livret du RENAU : M. VIROLLET Lionel, Mme DELESPINE Elodie, Mme DE ALMEIDA Emilie, Mme GERVOIS Peggy, Mme GIRARDEAU Virginie, M. BORNE Christophe, M. CHALAND Baptiste, Mme REYNIER Valérie, Mme SOCQUET Virginie, Mme DYE Jocelyne, Mme GAZZOLA Marine, Mme MANGE Sonia, Mme RUBIO Cristine, Mme LAUNET Emilie, Dr VALLOT Cécile
Avec la participation du groupe du livret du REULIAN : Mr Sébastien BOUCHUT, Mme Amandine ALLEMAND, Mme Carolane CAPONY, Mr Mathieu GUILLAUME, Mme Denise PASSEMARD, Mme Karine PONCHON, Mr Florian RIBELLES, Mme Anne Laurence ROLLAND, Mr Christophe TEMPERE
Travail dédié au Dr Mikaël MARTINEZ

- **Avec l'aide :** Mme Alexandra VERDUCI, Mme Béatrice MITHIEUX ,Dr Richard LANGLOIS (MCS) Dr Gaël GHENO (CHANGE)

VALIDATION :

- **Médecins coordonnateurs Urg'Ara**

Dr Pascale CAVALLI, Dr Jonathan DUCHENNE, Dr Stéphanie FEY DOSDA, Dr Tobias GAUSS, Dr Laure JAINSKY, Dr Loïc LAMBOLEY, Dr Véronique POTINET, Dr Anthony PROST, Dr Abdesslam REDJALINE, Dr Patrice SERRE, Dr Cécile VALLOT

- **Pharmaciens**

38 : CHU Grenoble Alpes : **Dr Agathe MORIN-NOEL**, Dr Christine CHEVALLIER BRILLOIT
42 : CHU Saint Etienne : Dr Gwenaël MONNIER
CH de Roanne : Dr Maud ROSSIGNOL
63 : CHU Clermont Ferrand : Dr Marie SPACZEK
69 : HCL : Dr Raphael KAVAFIAN, Dr Carole PAILLET
73 : CH Métropole Savoie (Chambéry) : Dr Anne-Cécile FEYEL DOBROKHOTOV, Dr Coline DUQUENNE, Dr Ludovic SYLVESTRE
74 : CH Annecy Genevois : Dr Emeline PINEAU-BLONDEL

- **Bureau de la Commission Paramédicale Urg'Ara :** Mr Antonin LASSALLE, Mme Virginie PETITJEAN, Mr Sébastien BOUCHUT, Mr Mathieu GUILLAUME, Mme Magali LACAN, Mr Olivier GIROUD

- **Comité scientifique Urg'Ara :** Dr Danièle AGI, Dr Florence BAGES-LIMOGES, Dr Jean-Baptiste BOUILLON-MINOIS, Dr Alain CARILLON, Mme Vanessa CATALDO, Dr Lazhar CHELIHI, Pr Guillaume DEBATY, Dr Jean-François FAGE, Mme Julie FREYSSENGE, Mme Manon KACED, Dr Marie-Emmanuelle LIMOGES, Dr Virginie LVOVSCHI, Pr Fares MOUSTAFA, Dr Thomas ROCHER, Dr Nicolas ROUSSEL, Pr Jeannot SCHMIDT, Dr Julien TURK, Pr Alain VIALLON, Pr Damien VIGLINO, Pr Karim TAZAROURTE, Pr Youri YORDANOV

- Les auteurs déclarent n'avoir aucun lien d'intérêt

SOMMAIRE

Thèmes	Pages
Sommaire détaillé des fiches du médicament ADULTE, classées par **DCI**	**6**
Sommaire des fiches du médicament PÉDIATRIQUE, classées par **DCI**	**11**
Recommandations HAS	**13**
Glossaire	**14**
Légende	**15**
Abréviations	**17**
Mode d'emploi PSE MICREL MP *mlh+*	**18**
Administration des médicaments par voie intranasale	**19**
Surveillance du patient	**20**
Fiches du médicament Adulte	**21**
Fiches du médicament Pédiatrique	**65**



Liens hypertexte des sommaires, dans la version numérique

Dans la version numérique de chaque fiche du médicament, un lien hypertexte est inclus en bas de page ramenant à ce sommaire



DCI	NOM commercial	Indication	Préparation	Posologie	Page
Acétyl-salicylate de lysine	Acide acétyl-salicylique® ASL panpharma®	SCA	À RECONSTITUER SCA : 500 mg/5 mL de NaCl 0,9%	SCA : 250 mg en IVD (soit 2,5 mL)	**22**
Acide tranéxamique	Exacyl®	Traumatisé sévère Choc hémorragique (sauf Hémo. digestive)	À DILUER 2 Amp soit 1g/100 mL de NaCl 0,9%	1g en IVL En 10 à 15 min	**23**
Adénosine	Krénosin®	Conversion TJ Diagnostic tachycardie	PURE 1ère dose : deux flacons 2ème dose : trois flacons	1ère dose : 12 mg 2ème dose : 18 mg En IVD FLASH suivi d'une rinçure	**24**
Adrénaline	Adrénaline®	Arrêt cardiaque	PURE 5 mg/5 mL	Asystolie : 1 mg toutes les 4 min Rythme choquable : 1 mg après le 3ème CEE puis toutes les 4 min	**25**
Adrénaline	Adrénaline®	Anaphylaxie	PURE Ampoule de 1 mg : prélever 0,5 mL PSE : A DILUER 0,5 mg/ 50 mL	0,5 mg en IM AR une fois Débuter vitesse : 0,5 mL/kg/h	**26**
Adrénaline	Adrénaline®	Anaphylaxie Aérosols	AEROSOLS Une ampoule de 5 mg PURE	5 mg en aérosol	**27**
Amiodarone	Cordarone®	AC	PURE 2 ampoules pures après 3ème CEE 1 ampoule pure après 5ème CEE	300 mg après 3ème CEE 150 mg après 5ème CEE Suivi d'une rinçure	**28**
Amiodarone	Cordarone®	Trouble du rythme	À DILUER PSE : 2 ampoules/ 20 mL	300 mg en 30 min PSE : vitesse 40 mL/h	**29**
Atropine sulfate	Atropine®	Bradycardie Trouble de conduction	PURE Préparer une ampoule pure	1 mg / en titration / 3 à 5 min En IVDL Max 3 mg	**30**
Ceftriaxone	Rocéphine®	Infection	À RECONSTITUER avec set de transfert dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9%	1 à 2 g selon type d'infection	**31**

DCI	NOM commercial	Indication	Préparation	Posologie	Page
Clonazépam	Rivotril®	État de mal épileptique	À DILUER Avec le solvant (1 mL d'EPPI)	0,015 mg/kg en IVD soit 1 mg pour un adulte 70 kg Demi-dose : sujet âgé et insuffisant respiratoire AR à 5 min	32
Diltiazem	Tildiem®	Tachycardie jonctionnelle	À RECONSTITUER Un flacon de 25 mg/ 10 mL de NaCl 0,9%	Dose de charge : 0,25 mg/kg en IVDL sur 2 à 5 min Volume en mL = poids (kg)/10	33
Éphédrine chlorhydrate	Ephédrine®	Hypotension ISR	Seringue préremplie PURE ou À DILUER pour 30 mg/10 mL	3 à 6 mg / 5 à 10 min	34
Enoxaparine	Lovenox®	STEMI < 12h Thrombolyse	Seringue préremplie prêt à l'emploi	Âge < 75 ans : 30 mg soit 0,3 mL en IV + 1 mg/kg soit 0,01 mL/kg en SC Âge> 75 ans : 0,75 mg/kg soit 0,0075 mL/kg en SC	35
Flumazénil	Anexate®	Coma aux benzodiazépines	Titration : PURE PSE : 2 ampoules PURES	Titration : 0,1 mg soit 1 mL/30 sec Jusqu'à levée dépression respiratoire PSE : 0,1 à 0,4 mg/h	36
Furosémide	Lasilix®	Insuffisance cardiaque	PURE	Naïf : 40 mg Patient sous furo : dose journalière en IV	37
Glucagon chlorhydrate	Glucagen®	Hypoglycémie	À DILUER avec son solvant	1 mg en IM ou SC	38
Glucose 30%	Glucose 30% ®	Hypoglycémie	PURE Préparer 2 ampoules pures	2 ampoules de 20 mL En IVDL	39
Héparine sodique	Héparine®	SCA (Angioplastie)	À DILUER PSE : 25000 UI / 50 mL	Bolus : 70 UI/kg Puis entretien : 12 UI/kg/h	40
Ipratropium	Atrovent®	Asthme, BPCO	AÉROSOL En association avec salbutamol	Un aérosol / 8h	41

DCI	NOM commercial	Indication	Préparation	Posologie	Page
Isosorbide dinitrate	Risordan®	OAP, NSTEMI HTA	PURE Préparer 2 ampoules pures	Bolus : 2 à 4 mg IVD /5 min PSE : débuter 1 mg/h puis augmenter / 5 min tant que PAS > 110 mmHg	**42**
Kétamine	Kétamine®	Antalgie Low dose	À DILUER 0,15 à 0,3 mg/kg /100 mL de NaCl 0,9%	0,15 à 0,3 mg/kg	**43**
Kétamine	Kétamine®	Antalgie intranasale	PURE Avec seringue 1 mL et embout MAD Volume selon tableau	1 mg/kg Volume à fractionner dans les deux narines	**44**
Kétamine	Kétamine®	Antalgie intramusculaire	PURE	2,5 mg/kg	**45**
Kétamine	Kétamine®	Sédation procédurale	À DILUER 200 mg / 20 mL	0,8 à 1 mg/kg	**46**
Kétamine	Kétamine®	ISR	PURE	2 à 3 mg/kg	**47**
Kétamine	Kétamine®	Sédation après ISR	A DILUER 200 mg/ 20 mL	1 mg/kg / 15 min	**48**
Kétoprofène	Profénid®	Antalgie : colique néphrétique, traumato, rhumato	À DILUER Un flacon poudre /100 mL de NaCl 0,9%	100 mg En IVL sur 20 min	**49**
Loxapine	Loxapac®	Agitation	En IM	50 à 100 mg	**50**
Méthyl-prednisolone	Solumédrol®	Asthme BPCO	À RECONSTITUER Puis DILUER dans une poche de 100 mL	1 à 2 mg/kg Sur 10 min	**51**
Midazolam	Hypnovel®	Sédation vigile IV	A DILUER 5 mg/ 5 mL de NaCl 0,9%	1 mg / 1 mg en titration En IVD	**52**

DCI	NOM commercial	Indication	Préparation	Posologie	Page
Midazolam	Hypnovel®	Sédation intra nasale	PURE Avec seringue de 1 mL : prélever l'ampoule complète soit 5mg/ 1 mL	Pulvériser avec embout MAD : 5 mg soit 1 mL à répartir dans les deux narines Sujet âgé : 2,5 mg soit 0,5 mL	**53**
Midazolam	Hypnovel®	État de mal épileptique Voie IM (en absence de VVP)	PURE Avec Amp. de 5 mg/1 mL : prélever 2 ampoules	IM : 0,15 mg/kg Soit 10 mg (2 mL) pour un adulte	**54**
Morphine chlorydrate	Morphine®	Antalgie	À DILUER : 10 mg/10 mL Concentration : 1 mg/mL	Titration de 2 à 3 mg toutes les 5 min tant que EN>3 Ou dose de charge : 0,1 mg/kg si douleurs intenses	**55**
Morphine chlorydrate	Morphine®	Antalgie Aérosol	AÉROSOL 2 ampoules	20 mg	**56**
Naloxone	Narcan®	Surdosage aux opiacés	Titration : À DILUER 1 ampoule/ 10 mL PSE : 4 ampoules/ 40 mL	Titration : 1 mL / 60 sec objectif FR > 12 PSE : vitesse = volume de la demi-dose de titration	**57**
Naloxone	Narcan®	Intranasale	PURE Préparer une ampoule pure avec embout MAD X2	Pulvériser une ampoule dans chaque narine	**58**
Noradrénaline	Noradrénaline®	État de choc	PSE : À DILUER Diluer 4 mg/ 40 mL (G5%) Concentration : 0,1 mg/mL	Débuter 1 mg/h soit vitesse 10 mL/h	**59**
Oxytocine	Syntocinon®	Accouchement hors maternité Atonie utérine	PURE 5 UI/1mL	5 UI En IVDL sur 1 min	**60**
Salbutamol	Ventoline® Salbutamol®	Asthme BPCO Hyperkaliémie	AÉROSOL Asthme : 5 mg	Asthme : 4 aérosols la 1ère heure	**61**

DCI	NOM commercial	Indication	Préparation	Posologie	Page
Sérum salé hypertonique (SSH)		TC grave	Poche de 50 mL de NaCl 0,9% + 3 amp de 10 mL NaCl 10% + 2 amp 10 mL NaCl 20%	1 à 1,5 mL/kg en débit libre	**62**
Ténectéplase 10000 UI	Métalyse®	STEMI < 12h (Thrombolyse)	Seringue préremplie prête à l'emploi 10 mL	Âge < 75 ans : 100 UI/kg en IVDL sur 5-10 sec Âge ≥ 75 ans : demi-dose à 50 UI/kg en IVDL sur 5-10 sec	**63**
Ténectéplase 10000 UI	Métalyse®	STEMI < 12h	CI de la fibrinolyse dans le STEMI		**64**

SOMMAIRE PÉDIATRIQUE

DCI / Nom Commercial

DCI	NOM commercial	Page
Acide Tranéxamique	Exacyl®	66
Adénosine	Krénosin®	67
Adrénaline AC	Adrénaline®	69
Adrénaline RACS	Adrénaline®	70
Adrénaline Anaphylaxie	Adrénaline®	72
Adrénaline aérosol	Adrénaline®	73
Amiodarone AC	Cordarone®	74
Atropine sulfate	Atropine®	75
Ceftriaxone	Rocéphine®	77
Clonazépam	Rivotril®	79
Flumazénil	Anexate®	81
Glucagon chlorhydrate	Glucagen®	83
Glucose 30%	Glucose 30%®	84
Ipratropium	Atrovent®	85
Kétamine analgésie low dose	Kétamine®	86
Kétamine intranasale	Kétamine®	87
Kétamine sédation procédurale	Kétamine®	88
Kétoprofène	Profénid®	90
Methylprednisolone	Solumedrol®	91
Midazolam état de mal épileptique	Hypnovel®	92
Midazolam Etat de mal Intranasale	Hypnovel®	93

DCI	NOM commercial	Page
Midazolam Anxiété Intranasale	Hypnovel®	**94**
Midazolam état de mal IM	Hypnovel ®	**95**
Morphine chlorydrate	Morphine®	**96**
Morphine chlorydrate oramorph	Morphine®	**98**
Naloxone IV	Narcan®	**99**
Naloxone Intranasale	Narcan®	**100**
Noradrénaline	Noradrénaline®	**101**
Salbutamol	Ventoline® Salbutamol®	**103**
Sérum salé hypertonique (SSH)		**104**

Le livret répond aux recommandations de l'HAS et ses préconisations sur la sécurité d'administration des médicaments

RÈGLES DES 5B DE L'HAS

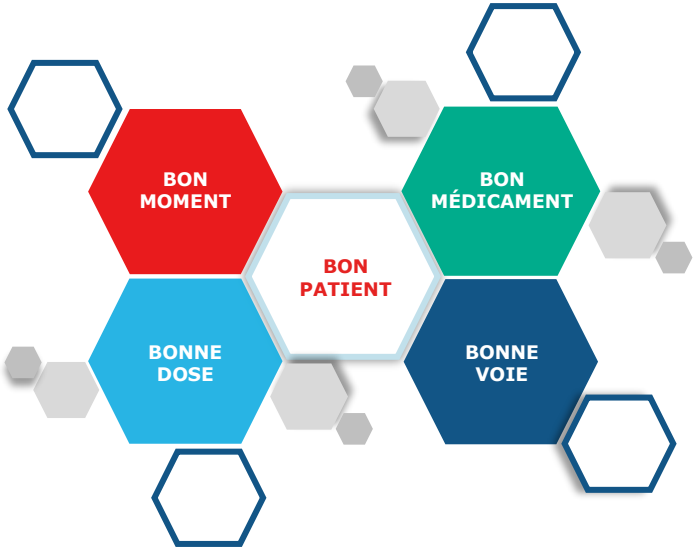
Les étapes à sécuriser et à retenir sont :

- **BON PATIENT**
- **BON MÉDICAMENT** injectable et soluté de perfusion
- **BONNE DOSE**
- **BONNE VOIE**
- **BON MOMENT**

RÈGLES DES 10 B en complément pour l'administration par perfusion :

- **BON CALCUL** de dilution pour la bonne concentration, le respect des protocoles de dilution du service
- **BONNE MANIÈRE** avec le choix du solvant de dilution, la préparation qui doit rester stérile, le respect du système clos, sans bulles (sans embolie gazeuse), sans particules, sans précipité, sans trouble, sans changement de couleur...
- **BON DÉBIT** avec le réglage et maintien du débit et la bonne programmation de la pompe ou du PSE
- **BON MONTAGE** (sécurisé, optimisé) des dispositifs médicaux utilisés, prévention des bolus de médicaments, minimisation des volumes résiduels et du volume du tronc commun
- **BONNE COMPATIBILITÉ** entre les produits perfusés, prévention des incompatibilités physico chimiques et des interactions

En cas de survenue d'un évènement indésirable grave : prévenir le médecin et déclarer l'évènement



GLOSSAIRE

	Surveillance scope
	Réaliser un ECG préalable
	Administration au pousse seringue électrique
	Dilution exclusive dans sérum glucosé 5%
	Dilution exclusive avec eau PPI
	Administration du médicament sur une voie dédiée
	Administration en intra musculaire
	Conservation au froid
	Administration par aérosol
	Attention / Vigilance
	Prescription hors AMM
	Administration à l'abri de la lumière
	Administration par voie intranasale
	Antidote
	Ampoule
	Seringue
	Poche
	Flacon

Toute dilution non spécifiquement désignée s'effectue avec du NaCl 0,9 %

Le G5 % est utilisé préférentiellement pour les amines (meilleure stabilité du médicament)
Le NaCl 0,9 % peut également être utilisé pour les amines

La conservation au froid concerne essentiellement les curares

LÉGENDE

Le système d'étiquetage s'appuie sur les codes internationaux de couleurs et de trames correspondant aux différentes classes pharmacologiques recommandées par la SFAR

Ce code permet une meilleure identification des drogues et assure la sécurité du patient

Recommandation ANSM : « *Harmonisation de l'étiquetage des ampoules et autres petits conditionnements de solutions injectables de médicaments* »

Code couleur à appliquer selon la classe pharmacologique de la spécialité :

Classe Pharmacologique et Couleur/Trame	Substances actives
Hypnotiques (hors benzodiazépines)	étomidate, kétamine, eskétamine, propofol
Benzodiazépines	diazépam, midazolam
Antagoniste des benzodiazépines	flumazénil
Curarisants	bésilate d'atracurium, bésilate de cisatracurium, mivacurium, bromure de pancuronium, bromure de rocuronium, succinylcholine, chlorure de suxaméthonium
Antagonistes des curarisants	néostigmine, sugammadex sodique
Opioïdes	alfentanil, fentanyl, morphine, péthidine, sufentanil, tramadol, nalbuphine, oxycodone
Antagonistes des opioïdes	naloxone
Sympathomimétiques	adrénaline, dobutamine, ephedrine, dopamine, noradrénaline, phényléphrine, salbutamol
Antihypertenseurs	urapidil, nicardipine
Anesthésiques locaux	bupivacaïne (avec ou sans adrénaline), lidocaïne (avec ou sans adrénaline), lévobupivacaïne, mépivacaïne (avec ou sans adrénaline), procaïne, ropivacaïne
Anticholinergiques	atropine
Anti-émétiques	dropéridol, granisétron, métoclopramide, métopimazine, ondansétron
Autres	amiodarone, oxytocine, piracétam, néfopam, nétilmicine, desmopressine, furosémide, héparine calcique/sodique…

LÉGENDE

Toutes les fiches ont été construites selon la même trame

INDICATION DU MÉDICAMENT

DCI – NOM COMMERCIAL®
Présentation(s) du médicament
Concentration du médicament

SPÉCIFICITÉ DU MÉDICAMENT

Classe pharmaceutique

⚠ **PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION**
Signifie qu'une fiche correspond à une seule indication médicale ; un médicament peut avoir jusqu'à 6 fiches

INDICATIONS :

Principales indications en situation d'urgence

Selon les indications, un médicament peut avoir plusieurs fiches spécifiées : tourner les pages !

CONTRE-INDICATIONS :

Les principales contre-indications sont mentionnées

La liste n'est pas exhaustive et concerne essentiellement la médecine d'urgence

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Préparation du patient avant l'administration du médicament
Surveillance particulière par rapport au médicament ou la pathologie en cause

PRÉPARATION :

Pour chaque médicament, le mode de préparation est détaillé dans la fiche : **PURE, À DILUER, À RECONSTITUER**
Pour la préparation d'une seringue : prélever les ampoules du médicament puis compléter jusqu'à un volume défini dans la fiche

MODE D'ADMINISTRATION

IVD : Intra Veineuse Directe
IVDL : Intra Veineuse Directe Lente (en seringue, temps précisé dans la fiche)
IVL : Intra Veineuse Lente (en poche). Temps précisé dans la fiche
IVSE : Intra Veineuse par Seringue Électrique
PSE : administration au Pousse Seringue Électrique

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Les données ne sont pas toujours mentionnées. Se référer à la monographie du médicament et au Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT)

INTERACTION PHYSICO-CHIMIQUE

Les IPC (Interactions Physiques Chimiques) ne sont pas mentionnées dans ce document : se référer à la monographie du médicament

POSOLOGIE :

Posologie selon les recommandations des référentiels Urg'Ara, ou des dernières recommandations des sociétés savantes

EFFETS SECONDAIRES :

La liste des effets secondaires n'est pas exhaustive mais concerne essentiellement le domaine de l'urgence. Pour plus d'informations, se référer à la monographie du médicament

ABRÉVIATIONS

AAG	Asthme Aigu Grave
AC	Arrêt Cardiaque
ACSOS	Agressions Cérébrales Secondaires d'Origine Systémique
AESP	Activité Électrique Sans Pouls
AINS	Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien
AIT	Accident Ischémique Transitoire
AMM	Autorisation de Mise sur le Marché
Amp	Ampoule
AOD	Anticoagulants Oraux Directs
ATCD	Antécédents
AVC	Accident Vasculaire Cérébral
AVCI	Accident Vasculaire Cérébral Ischémique
AVK	AntiVitamine K
BAV	Bloc Atrio-Ventriculaire
BAVU	Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle
BPCO	BronchoPathie Obstructive Chronique
CEE	Choc Électrique Externe
CI	Contre-Indication
DSA	Défibrillateur Semi-Automatique
ECG	Électro-Cardio-Gramme
ECPR	Extracorporeal Cardio Pulmonary Resuscitation
EME	État de Mal Épileptique
EN	Échelle Numérique
EP	Embolie Pulmonaire
EPPI	Eau pour Préparation Injectable
FA	Fibrillation Auriculaire
FC	Fréquence Cardiaque
FEVG	Fraction d'Éjection du Ventricule Gauche
Fl	Flacon
FOGD	Fibroscopie Oeso-Gastro-Duodénale
FR	Fréquence Respiratoire
FV	Fibrillation Ventriculaire
G5% ou SG5%	Glucose 5%
H ou h	Heure
HAS	Haute Autorité de Santé
HBPM	Héparine de Bas Poids Moléculaire
HNF	Héparine Non Fractionnée
HRP	Hématome Rétro-Placentaire
HTA	HyperTension Artérielle
HTIC	HyperTension Intra-Crânienne
HypoTA	Hypotension Artérielle
IDM	Infarctus Du Myocarde
IM	IntraMusculaire
INR	International Normalized Ratio
Ins	Insuffisance
IOT	Intubation Oro-Trachéale
ISR	Induction en Séquence Rapide
IV	Intra-Veineuse
J	Jour
KT	Cathéter
KTIO	Cathéter Intra-Osseux
MAP	Menace d'Accouchement Prématuré
MgSO4	Sulfate de Magnésium
MHC	Masque à Haute Concentration
MI	Membre Inférieur
Min	Minute
NaCl 0,9%	Chlorure de sodium
NIHSS	National Institute Health Score Scale
NSTEMI	Non-ST Élévation Myocardial Infarction
OAP	Œdème Aigu du Poumon
OMI	Œdème des Membres Inférieurs
PA	Pression Artérielle
PAD	Pression Artérielle Diastolique
PAM	Pression Artérielle Moyenne
PAS	Pression Artérielle Systolique
PEC	Prise En Charge
PIC	Pression Intra-Crânienne
PO	Per Os
PSM	Poste Sanitaire Mobile
QRS	Complexe QRS
QT	Segment QT
RA	Rétrécissement Aortique
RAU	Rétention Aiguë d'Urine
RACS	Récupération d'une Activité Circulatoire Spontanée
RCP	Réanimation Cardio Pulmonaire
ROT	Réflexe Ostéo-Tendineux
S ou sec	Seconde
SA	Semaine d'Aménorrhée
SAA	Syndrome Aortique Aigu
SAS	Syndrome d'Apnée du Sommeil
SAU	Service d'Accueil des Urgences
SC	Sous Cutané
SCA	Syndrome Coronarien Aigu
SNG	Sonde Naso-Gastrique
SpO_2	Saturation Pulsée en Oxygène
TC	Traumatisme Crânien
TIH	Thrombopénie Induite à l'Héparine
TNT	Trinitrine
TSV	Trouble Supra-Ventriculaire
TTT	Traitement
TV	Tachycardie Ventriculaire
VAS	Voies Aériennes Supérieures
VD	Ventricule Droit
VS	Ventilation Spontanée
VVC	Voie Veineuse Centrale
VVP	Voie Veineuse Périphérique
WPW	Wolf Parkinson White



MP*mlh+* Multi Mode d'emploi simplifié



Programmation du pousse seringues

Mise en marche : maintenir les touches ⌃ & ⌄, appuyées 3 secondes	888
Appuyer sur la flèche ⌃ pour régler la marque de la seringue.	cd
Appuyer sur la flèche ⌃ pour régler le volume de la seringue.	20
Programmation du débit.	06.3
Démarrage de la perfusion : maintenir ↵ appuyé jusqu'à l'apparition du symbole CAL .	15.7
Arrêt de la perfusion et extinction de l'appareil (OFF): Maintenir les touches ⌃ & ⌄, appuyées 3 secondes.	OFF

Pour changer le débit en cours de perfusion, programmer le nouveau débit et valider dans les trois secondes. Appuyer sur ↵ jusqu'à l'apparition du message CAL.

micrel Medical Devices

MP *mlh+*

Signaux d'avertissements

Pompe en attente : Affichage clignotant, démarrer la perfusion.	68.4
Piles faibles	+ -
Fin prochaine de la perfusion.	nE 1

Alarmes

En cas d'alarme, la perfusion est arrêtée. Éteindre le pousse seringue pour annuler l'alarme.	
OCClusion ou fin de perfusion.	OCC
Piles déchargées Éteindre le pousse seringue et changer les piles.	bAt
Alarmes techniques. Noter le code de l'alarme, éteindre et remettre en marche l'appareil, si l'alarme persiste, ne plus utiliser l'appareil.	E - -
Déplacement de seringue. S'assurer que les ailettes du tube de la seringue sont bien en place dans les encoches, que le bout arrondi du piston est dans la fente du poussoir et que la lanière autour du tube de la seringue est bien serrée.	SrG
Aucune marque et/ou volume de seringue n'a été sélectionné.	no

⚠ Se reporter au manuel d'utilisation pour plus d'informations.

La seringue de 50 mL ne peut être installée sur le PSE qu'avec un volume de 40 mL dans la seringue

Ajuster le volume final de la seringue à 40 mL

INDICATION :

Analgésie sédation en absence de VVP



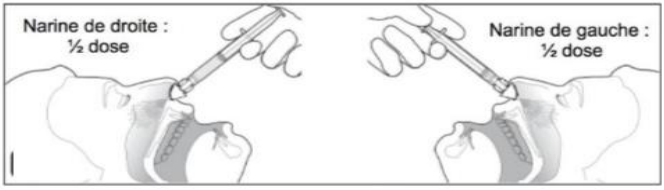
PRÉPARATION :

Dispositif spécifique :
Embout dispositif MAD® nasal + Seringue luer lock 1 mL

Installation du patient :
Désobstruction nasale si besoin
En semi assis à 45° ou en position couchée

Médicament :
Utilisation **PURE** : VIGILANCE sur la concentration du médicament et l'ampoule à utiliser
Utiliser les formes les plus concentrées

Utilisation :
Avec la seringue de 1 mL, prélever dans l'ampoule **PURE,** le volume à administrer du tableau des posologies des fiches médicaments. Le volume à administrer de la 1re dose du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré et qui reste dans l'espace mort de l'embout nasal).
Le volume de l'espace mort peut varier selon le type de dispositif MAD (de 0,06 à 0,15 mL) : choix du réseau d'un arrondi à 0,1 mL pour tous les dispositifs.
Prélever le 2e volume avec la même seringue et le même embout nasal.
Le volume de la 2e dose correspond au volume de la dose prescrite sans le volume de la purge de l'embout puisqu'il a déjà été purgé.
En résumé, il faut prélever et administrer les volumes indiqués dans les tableaux des fiches (tous les calculs sont déjà faits).
Double contrôle du dosage par 2 soignants.
Connecter l'embout nasal (MAD®) puis insérer l'embout dans la narine en direction du septum et presser le piston en 1 à 2 secondes
Volume maximal par narine : 1 mL (la dose peut être divisée entre les 2 narines)
Préférer 0,5 mL par narine pour une meilleure absorption.



SURVEILLANCE :

Score de sédation
FR, SpO_2, PA, FC, efficacité
Scope selon la molécule et la situation clinique
ANTIDOTE et matériel de réanimation disponible

CONTRE INDICATION :

Allergie au médicament utilisé
Traumatisme cranio facial
Altération de la conscience
Détresse respiratoire, instabilité hémodynamique
Traumatisme nasal, épistaxis, obstruction nasale complète

EFFETS INDÉSIRABLES :

Inconfort à l'instillation
Secondaires au médicament :sédation profonde, détresse respiratoire, nausées, vomissements

Score de Glasgow

L'échelle ou score de Glasgow est une méthode utilisée pour évaluer l'état de conscience du patient et son évolution

Le résultat à lui seul ne permet d'apprécier la profondeur du coma. Il convient d'étudier la variabilité des 3 critères cliniques (Y + V + M), déterminant un score compris entre 15 et 3

Y : Ouverture de Yeux		V : Réponse verbale		M : Réponse Motrice	
Spontanée	4	Orientée	5	Obéit à la demande verbale	6
À la demande	3	Confuse	4	Orientée à la douleur	5
À la douleur	2	Incohérente	3	Évitement non adapté	4
Aucune	1	Incompréhensible	2	Décortication (flexion à la douleur)	3
		Aucune	1	Décérébration (extension à la douleur)	2
				Aucune	1

La méthode de stimulation nociceptive recommandée est la pression appuyée au niveau sus-orbitaire ou la pression du lit unguéal avec un stylo. Le frottement ou le pincement de la peau doivent être évités

Score de Ramsay

Le score de Ramsay est une échelle simplifiée évaluant la profondeur de sédation chez un patient, en réponse à un stimuli

À l'aide de différents indicateurs, il déterminera l'adaptation des posologies aux besoins du patient, par une évaluation régulière de la surveillance neurologique

Réponse	Niveau
Patient anxieux, agité	1
Patient coopérant, orienté, calme	2
Patient répondant seulement aux ordres	3
Patient endormi mais avec une réponse nette à la stimulation de la glabelle ou à un bruit intense	4
Patient endormi avec une faible réponse aux stimulations nociceptives	5
Aucune réponse aux stimulations nociceptives	6

Le niveau s'interprète par :

- Un score à 2-3 : sédation optimale légère
- Un score à 4-5 : sédation profonde
- Un score à 6 : surdosage du sédatif

FICHES DU MÉDICAMENT PÉDIATRIQUE



ACIDE TRANEXAMIQUE - EXACYL®

Ampoule de 0,5 g/5 mL

Antifibrinolytique

INDICATIONS :

- PEC du traumatisé sévère : grade A, B et C
- PEC traumatisme à risque hémorragique (ex : fracture du fémur)
- Choc hémorragique **SAUF dans l'hémorragie digestive haute**

CONTRE-INDICATIONS :

- CI relative : ATCD convulsion prendre avis réa déchocage

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet, matériel de réanimation à proximité
À passer doucement en 10 à 15 min pour éviter le risque convulsif

PRÉPARATION :

Poids < 30 kg : Prélever le volume nécessaire (tableau) et diluer dans une poche de 50 mL de NaCl 0,9%



Poids > 30 kg : Prélever le volume nécessaire (tableau) et diluer dans une poche de 50 mL de NaCl 0,9%



POSOLOGIE :

POIDS ≤ 10 kg : 10 mg/kg
POIDS > 10 kg : 15 à 20 mg/kg

À passer dans l'heure après le traumatisme
(pas d'intérêt au delà de la 3ième heure après le traumatisme)

Poids (kg)	3	4	5	6	7	8	10	11	12	15	17	20	25	30	35	40	50
Dose en mg	30	40	50	60	70	80	100	200	200	250	300	350	400	500	600	700	1000
Volume en mL	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	2	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	10

Délai d'action : rapide ; Demi-vie : 3h

EFFETS SECONDAIRES :

- Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) si injection trop rapide
- Hypersensibilité
- Vertiges, malaises, hypotension, risque de **convulsions si injection trop rapide**

ADÉNOSINE - KRENOSIN®

Flacon de 6 mg/2 mL
Concentration : 3 mg/mL

Antiarythmique

INDICATIONS :

- Conversion des tachycardies jonctionnelles en rythme sinusal
- Aide au diagnostic des tachycardies : si tachycardie à complexes larges bien tolérée et tachycardie à complexes fins réguliers bien tolérée

CONTRE-INDICATIONS :

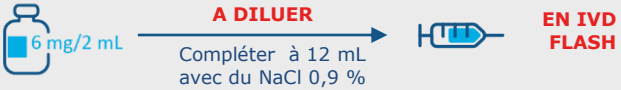
- Asthme sévère, BPCO
- Hypersensibilité à l'Adénosine
- BAV 2ème et 3ème degré
- Hypotension artérielle sévère
- QT long

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation, Scope, monitoring complet
ECG en place : à dérouler pendant l'injection en DII long
Il n'est pas nécessaire de préparer l'Atropine : demi-vie trop courte
À administrer en présence d'un médecin
Privilégier VVP de gros calibre , au plus près possible du cœur avec montage robinet à trois voies avec deux seringues pré-branchées (adénosine et une seringue de rinçure)
INJECTION RAPIDE « FLASH » suivie immédiatement d'une rinçure

PRÉPARATION : PURE

Poids < 30 kg pour la 1ère dose et les poids < 20 kg pour la 2ème dose :
A DILUER : Avec une seringue de 20 mL, prélever 1 flacon (6 mg/2 mL) et compléter à 12 mL avec NaCl 0,9 %.
Soit concentration : 0,5 mg/mL



Pour les poids ≥ 30 kg pour la 1ère dose et les poids ≥ 20 kg pour la 2ème dose : PRÉPARATION PURE



POSOLOGIE :

1ère dose : **0,1 mg/kg** à 0,2 mg/kg (max 6 mg)

2ème dose : **0,3 mg/kg** (*tableau des posologies => fiche suivante*).

Injection de la molécule **"FLASH" PUIS RINCER** avec 5 mL NaCl 0,9 %

Si TSV réfractaire après les 2 doses : envisager d'autres thérapeutiques antiarythmiques et avis spécialisé

Délai d'action : immédiate, demi-vie 10 sec ; Durée d'action : 1 minute

EFFETS SECONDAIRES :

- **Pause sinusale prolongée**, syncope, bradycardie, extrasystole ventriculaire, dyspnée, céphalées, sensation d'oppression thoracique, vertiges, flush facial
- Anxiété, angoisse, nausées, sensation de brûlure au point d'injection
- Asystolie

ADÉNOSINE - KRENOSIN®

Flacon de 6 mg/2 mL
Concentration : 3 mg/mL

Antiarythmique

Poids < 30 kg pour la 1ère dose et les < 20 kg pour la 2ème dose : A DILUER
Avec une seringue de 20 mL, prélever 1 flacon (6 mg/2 mL) et compléter à 12 mL avec NaCl 0,9 %

Pour les poids ≥ 30 kg pour la 1ère dose et les poids ≥ 20 kg pour la 2ème dose : PUR prélever un ou deux flacons

INJECTION RAPIDE « FLASH »
suivie immédiatement d'une rinçure

	PREMIÈRE DOSE 0,1 mg/kg		DEUXIÈME DOSE 0,3 mg/kg	
Poids (kg)	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**
3	0,3	0,5	0,9	2
4	0,4	1	1,2	2,5
5	0,5	1	1,5	3
6	0,6	1	1,8	3,5
7	0,7	1,5	2,1	4
8	0,8	1,5	2,4	5
10	1	2	3	6
12	1,2	2,5	3,6	7
14	1,4	3	4,2	8,5
17	1,7	3,5	5,1	10
20	2	4	6	2 mL PUR
25	2,5	5	7,5	2,5 mL PUR
30	3	1 mL PUR	9	3 mL PUR
35	3,5	1,2 mL PUR	10,5	3,5 mL PUR
40	4	1,3 mL PUR	12	4 mL PUR
50	5	1,7 mL PUR	15	5 mL PUR

ARRÊT CARDIAQUE

ADRENALINE – ADRENALINE®
Ampoule de 1mg dans 1 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétiques

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Arrêt cardiaque sur rythme choquable ou non choquable *(Cf. référentiel AC Urg'Ara)*

CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune dans l'AC

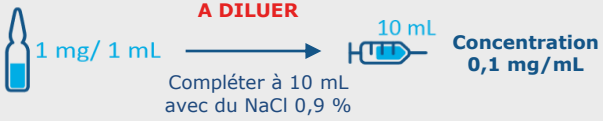
INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Voie dédiée

Scope, monitoring complet ; Matériel de réanimation prêt à l'emploi
VVP dédiée ; pose d'un KT intra-osseux en 1ère intention sauf si VVP en place
Injection au plus près du patient
Après chaque injection : flush avec 5 mL de NaCl 0,9% avec robinet débit libre et surélévation du bras (sauf si KTIO en place) et perfusé pendant 10 à 20 sec pour faciliter le passage de la drogue dans la circulation générale
Toujours bien vérifier le rythme et l'absence de RACS avant d'injecter l'adrénaline

PRÉPARATION :

Prélever une ampoule de 1 mg /1 mL
et compléter à 10 mL avec du NaCl 0,9%



POSOLOGIE :

RYTHME NON CHOQUABLE (asystolie, AESP)
Adrénaline le plus tôt possible
Dose poids selon tableau toutes les 4 min
(tous les 2 cycles d'analyse) **en IVD** ;
Débuter le plus tôt possible

RYTHME CHOQUABLE (FV, TV sans pouls) :
CEE le plus tôt possible
Dose poids selon tableau
après le 3ième CEE en IVD
puis toutes les 4 min
(tous les 2 cycles d'analyse)

Délai d'action/durée : immédiat

Poids (kg)	Dose (mg)	Volume à injecter (mL)
3	0,05	0,5
4	0,05	0,5
5	0,05	0,5
6	0,1	1
7	0,1	1
8	0,1	1
10	0,1	1
12	0,15	1,5
14	0,15	1,5
17	0,15	1,5
20	0,2	2
25	0,25	2,5
30	0,3	3
35	0,35	3,5
40	0,4	4
50	0,5	5

EFFETS SECONDAIRES :

- Sans objet dans l'indication d'arrêt cardiaque

RACS PSE

ADRENALINE – ADRENALINE®

Ampoule de 5 mg/5 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Instabilité hémodynamique après RACS (reprise activité cardiaque spontanée)

CONTRE-INDICATIONS :

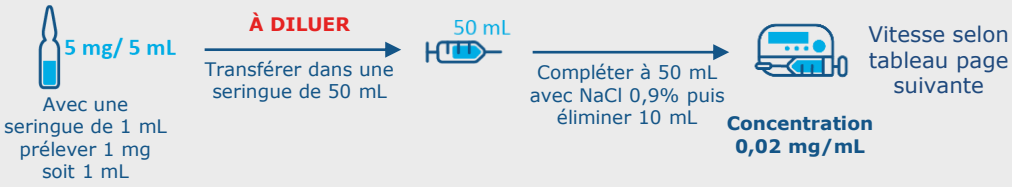
- Aucune en situation d'urgence vitale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi

PRÉPARATION :

Poids ≤ 10 kg : Avec une seringue de 1 mL, prélever 1 mg soit 1 mL et transférer dans une seringue de 50 mL puis compléter à 50 mL de NaCl 0,9%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume, au PSE. Purger le prolongateur. Concentration : 0,02 mg/mL



Poids > 10 kg : Avec une seringue de 50 mL, prélever 5 mg soit 5 mL et compléter à 50 mL de NaCl 0,9%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume au PSE et brancher le PSE. Purger le prolongateur
Concentration : 0,1 mg/mL



POSOLOGIE :

En post RACS, recours précoce à l'adrénaline en 1ère intention :

débuter à **0,1 à 0,2 µg/kg/min**

puis augmenter par palier de 0,1 µg/kg/min, selon tableau des posologies

Avis réa pédiatrique

ADRENALINE – ADRENALINE®

Ampoule de 5 mg/5 mL
Concentration : 1 mg/mL



Sympathomimétique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

Tableau des vitesses de PSE en mL/h

POIDS	0,2 µg/kg/min soit **12 µg/kg/h**	0,5 µg/kg/min soit **30 µg/kg/h**	1 µg/kg/min soit **60 µg/kg/h**	1,5 µg/kg/min soit **90 µg/kg/h**
3 kg	1,8	4,5	9	13,5
4 kg	2,4	6	12	18
5 kg	3	7,5	15	22,5
6 kg	3,6	9	18	27
7 kg	4,2	10,5	21	31,5
8 kg	4,8	12	24	36
10 kg	6	15	30	45
11 kg	1,3	3,3	6,6	9,9
12 kg	1,4	3,6	7,2	10,8
15 kg	1,8	4,5	9	13,5
17 kg	2	5,1	10,2	15,3
20 kg	2,5	6,3	12,6	18,9
25 kg	3	7,5	15	22,5
30 kg	3,6	9	18	27
35 kg	4,2	10,5	21	31,5
40 kg	4,8	12	24	36
50 kg	6	15	30	45

ANAPHYLAXIE

ADRENALINE – ADRENALINE®
Ampoule de 1 mg/1 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Anaphylaxie

CONTRE-INDICATIONS :

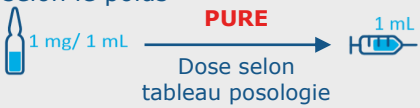
- Aucune en situation d'urgence vitale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :
Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi

PRÉPARATION :

1ère DOSE : Voie IM voie d'administration recommandée +++ le plus précocement. Prélever PURE la dose nécessaire selon le poids

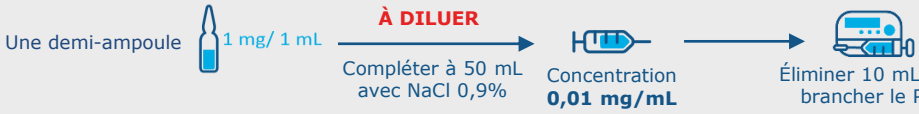
POSOLOGIE : : 0,01 mg/kg (max 0,5 mg)



Age	1-5 ans	6 – 12 ans	> 12 ans
Poids	< 20 kg	20- 40 kg	> 40 kg
Dose en mg et volume en mL	0,15	0,3	0,5

2ème dose : IM si les symptômes persistent à 5 min
Associer en même temps à un **remplissage vasculaire 10 mL/kg** de NaCl 0,9%

3ème DOSE : IV PSE
Indiqué si **anaphylaxie réfractaire** : absence d'amélioration après 2 injections IM, chez un patient scopé. Avec une seringue de 50 mL, prélever une demi-ampoule de 1 mg/1 mL soit 0,5 mg et compléter à 50 mL avec du NaCl 0,9%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume au PSE



Posologie : Débuter à **0,6 mL/kg/h** et titrer en augmentant ou diminuant la vitesse toutes les 3-5 minutes selon l'objectif de PAM (objectif PAM > 60 mmHg)

Vitesse initiale du PSE											
Poids (kg)	5	6	8	10	11	15	20	25	30	35	40
Vitesse en mL/h	3	3,6	4,8	6	6,6	9	12	15	18	21	24

EFFETS SECONDAIRES :

- Crises angineuses ; risque d'infarctus du myocarde, tachycardie sinusale
- Troubles du rythme à type de fibrillation ventriculaire

AÉROSOL

ADRENALINE – ADRENALINE®

Ampoule de 5 mg/5 mL
Concentration : 1 mg/mL

Sympathomimétique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Anaphylaxie si détresse respiratoire avec asthme
- Laryngite

CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune en situation d'urgence vitale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi

PRÉPARATION : PURE

A partir d'une ampoule de 5 mg/ 5 mL, prélever le volume nécessaire en fonction du poids et le vider dans le nébulisateur puis compléter à 5 mL avec du NaCL 0,9%

Dose selon tableau → 5 mg/ 5 mL → **A DILUER** → Compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%

POSOLOGIE :

0,5 mg/kg (dose max = 5 mg)

A administrer sur 20 min sous 6 à 8 L/min d'O_2 ou sous air

Poids (kg)	3	4	5	6	7	8	10	≥ 12
Dose (mg) = volume (mL)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	5

EFFETS SECONDAIRES :

- Crises angineuses ; risque d'infarctus du myocarde
- Tachycardie sinusale
- Troubles du rythme à type de fibrillation ventriculaire

ARRÊT CARDIAQUE

AMIODARONE – CORDARONE®

Ampoule de 150 mg /3 mL
Concentration : 50 mg/mL

Antiarythmique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Arrêt cardiaque sur rythme choquable
(Cf. référentiel AC Urg'Ara)

CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune dans l'AC

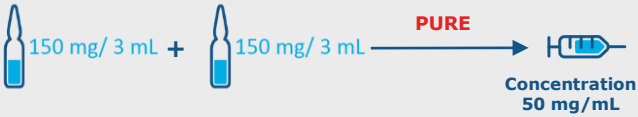
INSTALLATION ET SURVEILLANCE :




Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
VVP dédiée ; KT intra-osseux en 1ère intention sauf si VVP en place
Injection au plus près du patient
Après chaque injection : flush avec 5 mL de NaCl 0,9%, avec robinet débit libre et surélévation du bras (sauf si KTIO en place) et perfusé pendant 10 à 20 sec pour faciliter le passage de la drogue dans la circulation générale
En situation d'AC, amiodarone compatible avec NaCl 0,9%

PRÉPARATION :

Prélever **deux ampoules** soit 300 mg
PURE
Concentration 50 mg/mL



POSOLOGIE :

5 mg/kg après le 3ème et le 5ème CEE

En IVD suivie **d'un flush de 5 mL** de NaCl 0,9% après l'injection

Délai d'action/durée : immédiat

Poids (kg)	Dose (mg)	Volume à injecter (mL)
3	15	0,5
4	20	0,5
5	25	0,5
6	30	1
7	35	1
8	40	1
10	50	1
12	60	1,5
15	75	1,5
17	85	2
20	100	2
25	125	2,5
30	150	3
35	175	3,5
40	200	4
50	250	5

EFFETS SECONDAIRES :

- Sans objet dans l'indication d'arrêt cardiaque

ATROPINE SULFATE - ATROPINE®

Ampoule de 0,5 mg/1 mL
Concentration : 0,5mg/mL

Anticholinergique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Bradycardie induite par une augmentation du tonus vagal
- Bradycardie induite par une pathologie de la conduction cardiaque

CONTRE-INDICATIONS :

- Aucune en cas de détresse vitale
- Hypersensibilité à l'un des constituants
- Glaucome par fermeture de l'angle

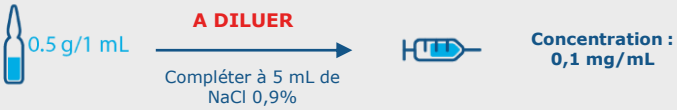
INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
ECG

PRÉPARATION :

Poids ≤ 20 kg : A DILUER

Prélever une ampoule de 0,5 mg et compléter à 5 mL
Soit concentration : 0,1 mg/mL
Pour les poids < 5 kg : prélever avec une seringue de 1 mL



Poids > 20 kg : PUR



POSOLOGIE :

0,02 mg/kg MAX 0,5 mg
AR si besoin
En IVD flash

Tableau des posologies selon poids : fiche suivante

EFFETS SECONDAIRES :

- Sécheresse buccale, trouble de l'accomodation
- Rétention d'urine
- Palpitations, tachycardie, arythmie

ATROPINE SULFATE - ATROPINE®

Ampoule de 0,5 mg/1 mL
Ampoule de 1 mg/1 mL
Seringue préremplie 1 mg/5 mL (0,2 mg/mL)



Anticholinergique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

Poids ≤ 20 kg : prélever une ampoule de 0,5 mg et compléter à 5 mL avec NaCL 0,9%
Soit concentration : 0,1 mg/mL

Poids (kg)	Dose (mg)	Volume à prélever (mL)
3	0,06	0,6
4	0,08	0,8
5	0,1	1
6	0,12	1,2
7	0,14	1,4
8	0,16	1,6
10	0,2	2
12	0,24	2,4
14	0,28	2,8
17	0,34	3,4
20	0,4	4

Poids > 20 kg : préparation PURE
Une ampoule de 0,5 mg/1 mL soit 0,5 mg/mL

> 20	0,5	1

CEFTRIAXONE - ROCEPHINE®

Flacon de 1 g

Antibiotique C3G

INDICATIONS :

- Infections aux germes sensibles à la ceftriaxone : méningite bactérienne

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux C3G
- Relative : nouveau-né jusqu'à un mois car souvent ictérique et risque de lithiase (perfusion avec Calcium)

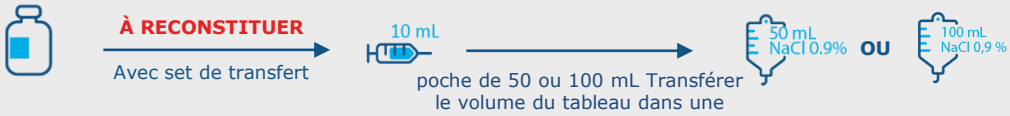
INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient selon sepsis associé
Allergie

PRÉPARATION : À RECONSTITUER

Reconstituer le flacon de 1 g avec 10 mL de NaCl 0,9 % = seringue mère
Soit concentration : 100 mg/mL
Prélever dans le flacon reconstitué (= seringue mère) la dose et le volume correspondant au poids selon tableau suivant et transférer dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9 %

A PASSER EN 30 MIN (sauf PURPURA en IVDL sur qq min)



POSOLOGIE :

100 mg/kg en une seule injection/j

≤ 2 ans = dose max : 1 g
(entre 3 mois et 12 mois peut être prescrit en 2 injections)

> 2 ans = dose max 4g/j et 2g/prise max
Si dose> 2g/j : répartir la dose en deux prises

EFFETS SECONDAIRES :

- Diarrhées, augmentation des enzymes hépatiques
- Éruption cutanée
- Céphalées, étourdissement, nausées, vomissements

Seringue mère : reconstituer le flacon de 1 g avec 10 mL de NaCl 0,9 %		
POSOLOGIE A 100 mg/kg/j en une fois		
Poids (kg)	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**
	Prélever dans le flacon reconstitué (= seringue mère) la dose et le volume correspondant au poids et **transférer dans une poche de 50 mL de NaCl 0,9 %**	
3	300	3
4	400	4
5	500	5
6	600	6
7	700	7
8	800	8
9	9000	9
10	1000	10
11	1100	11
15	1500	15
	Prélever dans le flacon reconstitué (= seringue mère) la dose et le volume correspondant au poids et **transférer dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9 %**	
20	2000	20
25	2500	25
30	3000	30
35	3500	35
40	4000	40

En 2 prises

CLONAZEPAM – RIVOTRIL®

Ampoule de 1 mg/1 mL
+ solvant

Benzodiazépine

INDICATIONS :

– État de mal épileptique.
A éviter en 1ère intention chez le mois de 3 mois

CONTRE-INDICATIONS :

– Allergie aux benzodiazépines
– Insuffisance respiratoire, SAS
– Insuffisance hépatique sévère
– Myasthénie

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt
ATTENTION AUX PAUSES RESPIRATOIRES

PRÉPARATION :

Poids < 25 kg : A DILUER Avec SOLVANT puis avec NaCL 0,9%
Prélever 1 ampoule de 1 mg, diluer avec 1 mL de solvant puis compléter jusqu'à 10 mL avec NaCl 0,9 %



Poids ≥ 25 kg : A DILUER AVEC SOLVANT



POSOLOGIE :

Première dose : **0,04 mg/kg** (dose max : 1 mg)

Deuxième dose à 5 min : **0,04 mg/kg** ou 0,02 mg/kg si dépression respiratoire

Injection **en IVDL sur 30 à 60 sec**

Purger le prolongateur avec la molécule jusqu'à l'entrée du cathéter puis injecter le produit sur 30 à 60 sec et RINCER +++

NB : même posologie pour les enfants ayant une gastrostomie
Délai d'action : immédiat Durée d'action : 3h

EFFETS SECONDAIRES :

– Dépression respiratoire, apnée
– Somnolence, troubles mnésiques, hypotonie musculaire, asthénie.
– Réactions d'hypersensibilité. hypotension artérielle., vomissements, nausées,
– Réactions paradoxales : agitation, agressivité, délire, irritabilité, cauchemars

CLONAZEPAM – RIVOTRIL®

Ampoule de 1 mg/1 mL
+ solvant



Benzodiazépine

Poids < 25 kg : PRÉPARATION : diluer 1 ampoule de 1 mg dans 1 mL de solvant puis compléter à 10 mL de NaCl 0,9 % avec du NaCL 0,9 % soit 0,1 mg/mL				
	1ère et 2ème DOSE à 0,04 mg/kg		**2ème dose si dépression respiratoire à 0,02 mg/kg**	
Poids (kg)	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**
3	0,12	1,2	0,06	0,6
4	0,16	1,6	0,08	0,8
5	0,2	2	0,1	1
6	0,24	2,4	0,12	1,2
7	0,28	2,8	0,14	1,4
8	0,32	3,2	0,16	1,6
10	0,4	4	0,2	2
12	0,48	4,8	0,24	2,4
15	0,56	5,6	0,28	2,8
17	0,68	6,8	0,34	3,4
20	0,8	8	0,4	4
Poids ≥ 25 kg : PRÉPARATION : A DILUER AVEC SOLVANT (ampoule + solvant)				
≥ 25	1	2	0,5	1

POIDS ≤ 10 kg

FLUMAZENIL - ANEXATE®

Ampoule de 1 mg/10 mL
Concentration : 0,1 mg/mL

ANTIDOTE

Antagonistes des benzodiazépines

INDICATIONS :

- Coma supposé par surdosage en benzodiazédines lorsque son état nécessite une intubation / ventilation mécanique, afin de l'éviter

CONTRE-INDICATIONS :

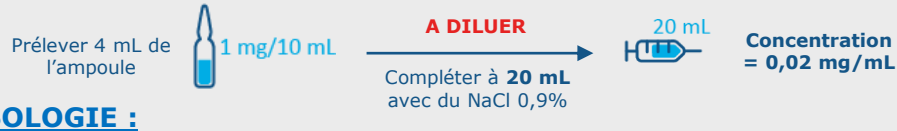
- Co-intoxication avec un produit pro-convulsivant (notamment tricycliques)
- ATCD connus d'épilepsie traité par benzodiazépines
- Allergie au flumazénil ou benzodiazépines
- Signes de surdosage aux antidépresseurs tricycliques

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation à proximité
Risque de convulsion chez le patient poly intoxiqué et le sujet épileptique connu

PRÉPARATION : A DILUER POIDS ≤ 10 kg

Avec une seringue de 20 mL, prélever 0,4 mg soit 4 mL de l' ampoule de 1 mg/10mL à compléter à 20 mL



POSOLOGIE :

TITRATION : 0,01 mg/kg (dose max : 0,2 mg/injection) en IVL sur 15 sec à renouveler si le degré de conscience souhaité n'est pas obtenu après 60 sec
Injection d'une nouvelle dose toutes les 60 sec jusqu'à la levée de la dépression respiratoire (dose max : 0,05 mg/kg ou 1 mg). Posologie selon tableau
Au-delà de 0,05 mg/kg sans réponse clinique, le diagnostic est remis en cause

ENTRETIEN au PSE : 0,01 mg/kg/h. Prélever 1 ampoule et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%. Vitesse selon tableau

Poids (kg)	3	4	5	6	7	8	10
Dose titration (mg)	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,1
Volume de titration (mL)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
Vitesse PSE entretien (mL/h)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5

Délai d'action de 30 sec à 3 min ; ½ vie d'élimination courte : de 40 à 80 minutes

EFFETS SECONDAIRES :

- Trouble du rythme ventriculaire
- **Crise convulsive tonico-clonique**
- Agitation, confusion, nausées, vomissement

POIDS > 10 kg

FLUMAZENIL - ANEXATE®

Ampoule de 1 mg/10 mL
Concentration : 0,1 mg/mL

ANTIDOTE

Antagonistes des benzodiazépines

INDICATIONS :

- Coma supposé par surdosage en benzodiazédines lorsque son état nécessite une intubation / ventilation mécanique, afin de l'éviter
- *Selon RFE SFMU-SRLF : PEC intoxication médicamenteuses et drogues récréatives*

CONTRE-INDICATIONS :

- Co-intoxication avec un produit pro-convulsivant (notamment tricycliques)
- ATCD connus d'épilepsie traité par benzodiazépines
- Allergie au flumazénil ou benzodiazépines
- Signes de surdosage aux antidépresseurs tricycliques

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation à proximité
Risque de convulsion chez le patient poly intoxiqué et le sujet épileptique connu

PRÉPARATION : PURE POIDS > 10 kg

Prélever une ampoule de 1 mg/10 mL PURE



POSOLOGIE :

TITRATION : préparation pure 0,01 mg/kg

Préparer 1 ampoule soit 1 mg, PURE dans une seringue de 10 mL
Posologie : 0,1 mg soit 1 mL toutes les 30 secondes jusqu'au levée de la dépression respiratoire et obtention d'un réveil (état de vigilance compatible avec une ventilation efficace) et protection des voies aériennes. Ne pas dépasser 2 mg
Au-delà de 0,05 mg/kg sans réponse clinique, le diagnostic est remis en cause

ENTRETIEN au PSE : 0,01 mg/kg/h soit 0,1 à 0,5 mg/h
Prélever 1 ampoule PURE. Vitesse selon tableau

Poids (kg)	12	14	17	20	25	30	35	40	50
Entretien (mL/h)	1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	3,5	4	5

Délai d'action de 30 sec à 3 min ; ½ vie d'élimination courte : de 40 à 80 minutes

EFFETS SECONDAIRES :

- Trouble du rythme ventriculaire
- Crise convulsive tonico-clonique
- Agitation, confusion, nausées, vomissement

GLUCAGON CHLORHYDRATE – GLUCAGEN®

Flacon de 1 mg + solvant

Hormone hyperglycémiante

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Hypoglycémie chez le patient diabétique sous insuline AVEC trouble de la conscience si correction par voie orale impossible

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie au glucagon
- Phéochromocytome

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance conscience
Surveillance glycémie capillaire

PRÉPARATION :

Diluer le flacon de 1 mg avec son solvant fourni (1 mL) avec seringue fournie

Ou utiliser une seringue à tuberculine avec 1 mL d'EPPI



POSOLOGIE :

0,03 mg/kg en IM ou SC soit :

Poids < 25 kg (enfant de moins de 6 à 8 ans) : **0,5 mg** en IM ou SC

Poids ≥ 25 kg (enfant de plus de 6 à 8 ans) : **1 mg** en IM ou SC

EFFETS SECONDAIRES :

- Nausées, vomissements
- Hypoglycémie, hypocalcémie

GLUCOSE 30%
Ampoule de 3 g/10 mL

INDICATIONS :
- Hypoglycémie sévère

CONTRE-INDICATIONS :
- **NOUVEAU-NE**
- Hypersensibilité au maïs
- Hyperglycémie non contrôlée, diabète décompensé, coma hyperosmolaire, acidose lactique
- Insuffisance cardiaque aiguë

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :
Surveillance conscience
Surveillance glycémie capillaire / 5 min initialement

PRÉPARATION :
Préparer une ampoule PURE



POSOLOGIE :
0,7 mL/kg

Soit arrondi à :

POIDS < 10 kg : 5 mL

10 kg ≤ POIDS < 20 kg : 10 mL

POIDS > 20 kg : 20 mL

Contrôle de la glycémie toutes les 30 min jusqu'à ce que la glycémie soit stable

EFFETS SECONDAIRES :
- Allergie
- Irritation au site de perfusion

IPRATROPIUM – ATROVENT®

Enfant : solution pour inhalation 0,25 mg/mL
Adulte : solution pour inhalation 0,5 mg/2 mL

Anticholinergique





INDICATIONS :

– Asthme

CONTRE-INDICATIONS :

– Aucune

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance SpO_2, FR, signes cliniques respiratoires
Matériel de réanimation à proximité

PRÉPARATION : en nébulisation

Vider une dosette dans le nébulisateur PUR
En association avec β2mimétiques



Administration :
Sous O_2 : 6 à 8 L/min
Durée d'un aérosol : 15 à 20 min

POSOLOGIE :

Toujours en association avec β2mimétiques dans le 1er aérosol puis salbutamol seul dans les 3 suivants de la 1ère heure dans l'asthme aigu grave

Poids < 20 kg : dosette de **0,25 mg/1 mL**

Poids ≥ 20 kg : dosette de **0,5 mg/2 mL**

Ipratropium : **trois fois par jour soit /8 h**

EFFETS SECONDAIRES :

- Sècheresse buccale, toux, tachycardie
- Nausées, céphalées, vertiges
- Glaucome par fermeture de l'angle, mydriase

KÉTAMINE LOW DOSE IV ANALGÉSIE

KETAMINE – KETAMINE®
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Analgésie. Alternative à la morphine (toxicomane, allergie à la morphine, patient précaire au niveau respiratoire ou hypotendu, douleur difficile à contrôler)
- Douleurs réfractaires aux opiacés IV ou en coanalgésie avec la morphine en cas de stratégie multimodale

CONTRE-INDICATIONS :

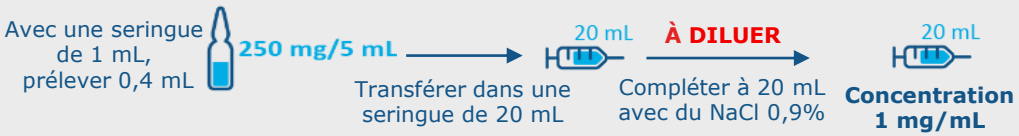
- Hypersensibilité à la Kétamine
- Schizophrénie
- HTA, coronaropathie sévère
- Sténose ou chirurgie trachéale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance scope, ou au moins SpO_2, FR, PA, état de conscience, score de Ramsay
VIGILANCE si association avec morphine et meopa : risque dépression respiratoire
STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ

PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

Avec une seringue de 1 mL, prélever 0,4 mL (soit 20 mg) de l'ampoule de 250 mg/5 mL puis transférer le volume dans une seringue de 20 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%
Concentration : 1 mg/mL
Posologie selon le tableau ci-dessous



POSOLOGIE :

ANALGÉSIE : 0,2 mg/kg à administrer en IVDL à la seringue

Tableau des posologies à 0,2 mg
concentration 1 mg/mL

Poids (kg)	3	4	5	6	7	8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	50
Dose en mg et volume en mL	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10
	Volume à prélever avec une seringue de 1 ou 2 mL à partir de la seringue mère diluée à 1 mg/mL															

EFFETS SECONDAIRES :

- Hallucinations, cauchemar, désorientation, nystagmus, agitation favorisée par la stimulation sonore, troubles psychiques
- Anxiété, dysphorie, mouvements anormaux, hypotension, dépression respiratoire ou apnée, nausées, vomissements, hypersialorrhée

ANALGÉSIE INTRA NASALE

KETAMINE – KETAMINE®
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :
- **Analgésie** pour les gestes douloureux de courte durée

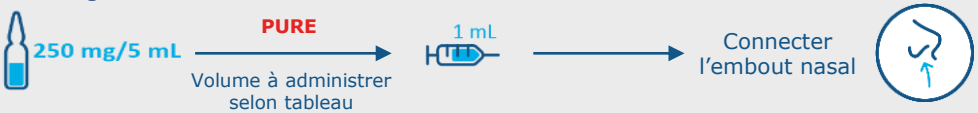
CONTRE-INDICATIONS :
- Hypersensibilité à la Kétamine
- < 6 mois
- CI à la voie intranasale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance saturomètre : FC, SpO_2, FR, score de sédation
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Pré-oxygénation recommandée
STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ

PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever dans l'ampoule de 250 mg/5 mL PURE, le volume à administrer selon le tableau
Connecter l'embout nasal (MAD)
Puis pulvériser le volume à administrer dans une narine ou deux narines
Au delà de 0,5 mL : fractionner le volume dans les deux narines, moitié à droite, moitié à gauche



POSOLOGIE :

1ère dose : 1 à 1,5 mg/kg
2ème dose : (après 5-10 min) : 1 mg/kg
Délai d'action 5-10 min

POIDS (kg)	10	12	15	20	25	35	40	≥ 50
1ère dose (µg)	10	15	20	30	35	50	60	75
Volume 1ère dose (mL)	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	1,2	1,6
Volume 2ème dose (mL)	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1

Prélever et administrer le volume du tableau. *NB : le volume à administrer de la 1ère dose du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré). Le volume de la 2ème dose correspond au volume de la dose prescrite sans le volume de purge de l'embout*

EFFETS SECONDAIRES :
- Hallucinations, cauchemar, désorientation, nystagmus, agitation favorisée par la stimulation sonore, troubles psychiques
- Anxiété, dysphorie, mouvements anormaux, hypotension, dépression respiratoire ou apnée, nausées, vomissements, hypersialorrhée

SÉDATION PROCÉDURALE

KETAMINE – KETAMINE®
Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

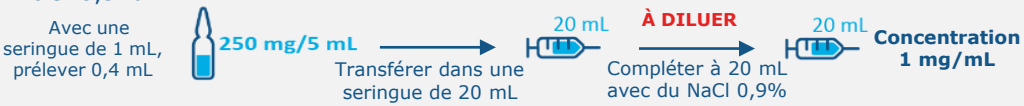
INDICATIONS :
- Sédation procédurale

CONTRE-INDICATIONS :
- Hypersensibilité à la Kétamine
- Schizophrénie
- HTA, coronaropathie sévère
- Sténose ou chirurgie trachéale

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :
Scope, monitoring complet, PNI/3 min, SpO_2 , $EtCO_2$ (lunettes)
PRÉ-OXYGÉNATION : O_2 > 15 L/min MHC : débuter 3 à 5 min avant sédation et maintenir jusqu'au réveil
Matériel de réanimation à proximité, BAVU à côté du patient, aspiration prête branchée
PAS d'association avec MEOPA, ni morphine : risque de dépression respiratoire
Pas d'association systématique avec du Midazolam sauf si apparition de troubles neuropsychiques
À administrer dans une atmosphère calme avec communication thérapeutique
STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ

PRÉPARATION :

POIDS < 20 kg : préparer une seringue avec une **CONCENTRATION de 1 mg/mL** Avec une seringue de 1 mL, prélever 0,4 mL de l'ampoule de 250 mg/5 mL puis transférer dans une seringue de 20 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%



POIDS 20 kg - 50 kg : préparer une seringue avec une **CONCENTRATION de 5 mg/mL** avec une seringue de 20 mL, prélever 100 mg soit 2 mL de l'ampoule de 250 mg/5 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%



POIDS > 50 kg : préparer une seringue avec une **CONCENTRATION de 10 mg/mL** avec une seringue de 20 mL, prélever 200 mg soit 4 mL de l'ampoule de 250 mg/5 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9% si besoin



POSOLOGIE :
Injecter 0,5 mg/kg à injecter LENTEMENT en 30 à 60 sec
Jusqu'à atteindre l'objectif de sédation et compléter si besoin avec 0,5 mg/kg supplémentaire

TABLEAU DES POSOLOGIES : FICHE SUIVANTE

Délai d'action : 1 à 3 min ; Durée d'action : 10 min jusqu'à 60-90 min

EFFETS SECONDAIRES :
- Vertiges, dysphorie, hallucinations, cauchemars, désorientation, nystagmus, **agitation favorisée par la stimulation sonore,** troubles psychiques, anxiété, mouvements anormaux
- Laryngospasme, apnée, syncope, AC

KETAMINE – KETAMINE®

Ampoule de 250 mg/5 mL
Concentration : 50 mg/mL

Hypnotique

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

Dose et volume de Kétamine pour une posologie de 0,5 mg/kg

POIDS < 20 kg

Avec une seringue de 1 mL, prélever 20 mg soit 0,4 mL de l'ampoule de l'ampoule de 250 mg/5 mL puis transférer dans une seringue de 20 mL et compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%

DILUTION 20 mg/20 mL
CONCENTRATION 1 mg/mL

Poids (kg)	Dose en mg	volume en mL
3	1,5	1,5
4	2	2
5	2,5	2,5
6	3	3
7	3,5	3,5
8	4	4
10	5	5
12	6	6
15	7,5	7,5
17	8,5	8,5

POIDS 20 - 50 kg

Avec une seringue de 20 mL, prélever 100 mg soit 2 mL de l'ampoule de 250 mg/5 mL puis compléter à 20 mL avec du NaCl 0,9%

DILUTION 100 mg/20 mL
CONCENTRATION 5 mg/mL

	Dose en mg	Volume en mL
20-29	10	2
30-39	15	3
40-49	20	4
> 50	**Cf. Livret adulte 200 mg/20 mL concentration 10 mg/mL**	

KÉTOPROFÈNE - PROFENID®

Ampoule de 100 mg/4 mL

AINS

INDICATIONS :

Antalgie de
- Colique néphrétique
- Douleur d'origine traumatique ou rhumatologique

CONTRE-INDICATIONS :

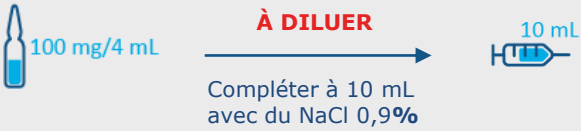
- **VARICELLE** (risque de fasciite nécrosante)
- Ulcère gastro duodénal en poussée évolutive
- Hémorragie gastro-intestinale, cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en évolution
- À éviter en début de grossesse, puis CI après 24 SA
- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance rénale sévère
- Hypersensibilité au kétoprofène
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Traitement de la douleur
Évaluation de la douleur

PRÉPARATION : A DILUER

Prélever une ampoule et diluer dans 10 mL de NaCl 0,9%
Soit concentration : 10 mg/mL



POSOLOGIE :

Age > 1 an

1 mg/kg/8h en IVL à la seringue sur 5 min

Si injection sur moins de 5 min : injection douloureuse

Poids (kg)	10	12	14	17	20	25	30	35	40	50
Volume (mL)	1	1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	3,5	4	5

EFFETS SECONDAIRES :

- Hypersensibilité
- Dyspepsie, douleur abdominale, nausées, vomissements

METHYLPREDNISOLONE – SOLUMEDROL®

Flacon poudre de 120 mg

Corticoïde de synthèse

INDICATIONS :

- Exacerbation asthme
- Dans l'Anaphylaxie, indiqué uniquement si détresse respiratoire de type asthme
- Réactions inflammatoires

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à la méthylprednisolone
- Infection virale évolutive
- Ulcère gastroduodénal

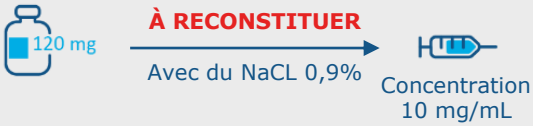
INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance clinique standard !

PRÉPARATION :

Reconstituer le flacon poudre avec du NaCl 0,9 %, pour avoir une concentration de 10 mg/mL

Ex : Flacon de 120 mg : diluer dans 12 mL



Poids (kg)50	Dose (mg)	Volume à injecter (mL)
3	3	0,3
4	4	0,4
5	5	0,5
6	6	0,6
7	7	0,7
8	8	0,8
10	10	1
12	12	1,2
15	15	1,5
20	20	2
25	25	2,5
30	30	3,5
35	35	3,5
40	40	4
50	50	5

POSOLOGIE :

1 à 2 mg/kg selon indication

Cf : tableau des posologies pour 1 mg/kg

EFFETS SECONDAIRES :

- Réactions anaphylactoïdes, prurit
- Hyper / hypotension artérielle, insuffisance cardiaque, arythmie
- Hémorragie digestive, nausées

ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE BUCCAL ANXIOLYSE PER OS

MIDAZOLAM - HYPNOVEL®
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Benzodiazépine

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Anxiolyse et sédation légère per os
- État de mal épileptique buccal ou sub jugal (hors nouveau–né)

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Anxiolyse : saturomètre : PA, FC, FR, SpO_2 (objectif ≥ 94%), score de sédation
Etat de mal épileptique : scope
ANTIDOTE **Anexate à proximité**

PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL prélever PUR, le volume en fonction du tableau des posologies/poids



POSOLOGIE :

BUCCAL OU SUBJUGAL : 0,3 mg/kg (dose max : 10 mg)

Tirez doucement la joue de l'enfant. Insérez l'extrémité de la seringue sur le côté de sa bouche, entre la gencive et la joue (dans la cavité buccale). Poussez doucement sur le piston. Veillez à ce que le produit ne ressorte pas de la bouche. Si nécessaire, administrez lentement la moitié de la dose d'un côté puis l'autre de l'autre côté

Poids (kg)	5	6	7	8	10	12	14	17	20	25	30	35	40	50
	Prélever avec une seringue de 1 mL													
Dose (mg)	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	5,1	6	7,5	10	10	10	10
Volume (mL)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	2	2	2

Début d'action : 15 min Durée d'action : 45 à 60 min

EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE INTRANASAL

MIDAZOLAM - HYPNOVEL®
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Benzodiazépine

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- État de mal épileptique en absence de VVP disponible

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Scope : PA, FC, FR, SpO_2 (objectif ≥ 94%)
Cf. fiche Intra-nasal
ANTIDOTE **Flumazénil à proximité**

PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever le volume en fonction du tableau des posologies/poids, puis adapter l'embout spécifique MAD



POSOLOGIE :

INTRANASAL : 0,3 mg/kg

Poids (kg)	5	6	7	8	10	12	14	17	20	25	30	35	40	50
	Prélever avec une seringue à tuberculine jusqu'à 17 kg													
Dose (mg)	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	5,1	6	7,5	10	10	10	10
Volume (mL)	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	2	2	2

Prélever et administrer le volume du tableau
NB : le volume à administrer de la 1ère dose du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré)
Prélever et administrer les volumes du tableau

Début d'action : 10 à 15 min Durée d'action : 30 à 60 min

EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

ANXIÉTÉ INTRANASAL

MIDAZOLAM - HYPNOVEL®
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Benzodiazépine

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Anxiété modérée à intense dans situations : suture, point de suture, ablation CE, pose VVP, soins dentaires, PL

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité
- TC, troubles de la conscience
- CI à la voie nasale
- Enfant < 6 mois

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Scope : PA, FC, FR, SpO_2 (objectif ≥ 94%)
Cf. fiche Intra-nasal p.25
ANTIDOTE **Flumazénil à proximité**

PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever dans l'ampoule 5 mg/1 mL, le volume à administrer du tableau puis connecter l'embout nasal et pulvérisation la moitié du volume dans chaque narine



POSOLOGIE :

INTRANASAL : 0,4 mg Fractionner le volume dans les deux narines

Poids (kg)	8	10	12	17	20	25
Dose (mg)	3	4	5	6	8	10
Volume à administrer (mL)	0,7	0,9	1,1	1,3	1,7	2,1

Prélever et administrer les volumes du tableau. *Le volume à administrer du tableau correspond au volume de la dose prescrite auquel est ajouté 0,1 mL pour purger l'embout nasal (0,1 mL non administré à l'enfant)*

Début d'action : 10 à 15 min Durée d'action : 30 à 60 min

EFFETS SECONDAIRES :

- Inconfort et brulure nasale ; sédation profonde et réaction paradoxale rare
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée, nausées, vomissements

ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE IM

MIDAZOLAM - HYPNOVEL®
Ampoule de 5 mg/1 mL
Concentration : 5 mg/mL

Benzodiazépine

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- État de mal épileptique en absence de VVP disponible

CONTRE-INDICATIONS :

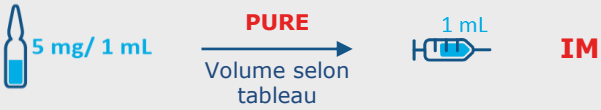
- Hypersensibilité
- Insuffisance respiratoire, SAS
- Insuffisance hépatique sévère aiguë ou chronique
- Myasthénie

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Scope : PA, FC, FR, SpO_2 (objectif ≥ 94%)
ANTIDOTE **Flumazénil à proximité**

PRÉPARATION :

Prélever le volume en fonction du tableau des posologies/poids, et injecter en Intramusculaire



POSOLOGIE :

0,2 mg/kg en IM

Ajouter un peu d'air (comme pour les vaccins pour purger l'aiguille)
Dose max 10 mg

Poids (kg)	5	6	7	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
Dose (mg)	1	1,2	1,4	1,6	2	2,4	2,8	4	5	6	7	8	10
Volume (mL)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2

EFFETS SECONDAIRES :

- **Dépression respiratoire**, apnée, dyspnée, arrêt respiratoire
- Hypotension, bradycardie, arrêt cardiaque
- Confusion, euphorie, hallucinations, agitation, somnolence, ataxie, amnésie, hyperactivité
- Mouvements involontaires
- Hypersensibilité, prurit, urticaire, éruption cutanée
- Nausées, vomissements

INTRA - VEINEUX

MORPHINE CHLORHYDRATE – MORPHINE®

Ampoule de 10 mg/1 mL
Concentration : 10 mg/mL

Antalgique opiacé

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Traitement de la douleur

CONTRE-INDICATIONS :

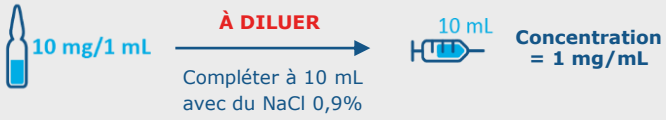
- Hypersensibilité aux produits
- Prudence si trouble neurologique ou respiratoire en évolution

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance SpO_2, FR, score de sédation
Matériel de réanimation à proximité
STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ
Évaluation de la douleur : EN ou ALGOPLUS ou BOS3 chez le patient non communiquant
Ne pas administrer la morphine par voie IM ou SC
ANTIDOTE **Naloxone à proximité**

PRÉPARATION : À DILUER

Ampoule de 10 mg/1 mL :
Prélever une ampoule de 10 mg/1 mL et compléter à 10 mL avec du NaCl 0,9%



POSOLOGIE :

AGE < 6 MOIS : 0,05 mg/kg/ 5 min soit 0,05 mL/kg/ 5 min
A partir de la seringue mère (10 mg/10 mL), prélever le volume nécessaire avec une seringue de 1 mL

Poids (kg)	3	4	5	6	7	8
Volume à injecter (mL)	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4

AGE > 6 MOIS : 0,1 mg/kg puis 0,05 mg/kg toutes les 5 min (max 3 mg par injection)
Si besoin, à partir de la seringue mère, (10 mg/10 mL), prélever le volume avec une seringue de 1 ou 2 mL

TABLEAU DES POSOLOGIES : PAGE SUIVANTE

EFFETS SECONDAIRES :

- Nausées, vomissements (facteur de risque = mal des transports)
- Sédation, dépression respiratoire
- Bradycardie, hypotension, constipation, rétention urinaire, réactions anaphylactoïdes

INTRA - VEINEUX

MORPHINE CHLORHYDRATE – MORPHINE®
Ampoule de 10 mg/1 mL
Concentration : 10 mg/mL



Antalgique opiacé

AGE > 6 MOIS jusqu'à 50 kg

TITRATION IV MORPHINE
0,1 mg/kg puis 0,05 mg/kg toutes les 5 min
(max 3 mg par injection)

Poids < 20 kg : prélever le volume dans la seringue mère avec une seringue de 1 ou 2 mL

Poids (kg)	DOSE DE CHARGE INITIALE 0,1 mg/kg (mg et mL)	BOLUS DE TITRATION 0,05 mg/kg/ 5 min (mg et mL)
6	0,6	0,3
7	0,7	0,3
8	0,8	0,4
9	0,9	0,4
10	1	0,5
12	1,2	0,6
15	1,5	0,7
17	1,7	0,8
20	2	1
25	2,5	1,2
30	3	1,5
35	3	1,7
40	3	2
50	3	2,5

PER OS

MORPHINE CHLORHYDRATE – ORAMORPH®

Unidose (pipette) de 10 mg/5 mL
Concentration de 2 mg/mL
Ou solution buvable 20 mg/mL : 1 goutte = 1,25 mg
(16 gouttes = 1 mL)



Antalgique opiacé

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Traitement de la douleur

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité aux produits
- Prudence si trouble respiratoire ou neurologique en évolution

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Surveillance SpO_2, FR, score de sédation évaluation douleur
STUPÉFIANT = TRAÇABILITÉ
Naloxone à proximité
Pas de posologie unique. La bonne dose est celle qui soulage le patient sans effet indésirable majeur

PRÉPARATION ET POSOLOGIE :

Enfant < 6 mois : dose de charge 0,1 mg/kg

Faibles doses initiales, augmenter intervalle et intensifier la surveillance
Administration suivante : 0,1 mg/kg toutes les 20 min, maximum 3 prises

	dose de charge 0,1 mg/kg		Puis titration 0,1 mg/kg	
Poids (kg)	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**	**Dose (mg)**	**Volume (mL)**
3	0,3	0,15	0,3	0,15
4	0,4	0,2	0,4	0,2
5	0,5	0,25	0,5	0,25
6	0,6	0,3	0,6	0,3

Enfant > 6 mois : dose de charge 0,5 mg/kg ou 0,2 mg/kg

Titration per os ensuite possible avec une dose per os de 0,2 mg/kg/ 20 min jusqu'à analgésie suffisante toutes les 20 min, maximum 3 prises

	dose de charge : 0,5 mg/kg			Dose initiale ou dose titration de 0,2 mg/kg		
Poids (kg)	**Dose (mg)**	**Unidose (mL)**	**Sol buv (gouttes)**	**Dose (mg)**	**Unidose (mL)**	**Sol buv (gouttes)**
8	4	2	3	1,6	0,8	1
10	5	2,5	4	2	1	1
15	7,5	3,5	6	3	1,5	2
18	9	4,5	7	4	2	3
20	10	5	8	4	2	3
25	12,5	6	10	5	2,5	4
30	15	7,5	12	6	3	5
35	17,5	8,5	14	7	3,5	6
40	20	10	16	8	4	6

EFFETS SECONDAIRES :

- Somnolence : diminuer les doses si efficacité antalgique obtenue, constipation

NALOXONE - NARCAN®

Ampoule de 0,4 mg/1 mL

Antagonistes des morphiniques

ANTIDOTE

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Surdosage aux opiacés lorsque l'état du patient nécessite une intubation/ventilation mécanique afin de l'éviter ; traitement de lal dépression respiratoire

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à la Naloxone ou aux morphiniques

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet ; Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Arrêter les opioïdes, stimuler le patient, débuter Oxygène si SpO_2 < 90 % et/ou FR sous les seuils :
< 1 an : FR < 20/min 1 à 5 ans : FR > 15/min âge > 5 ans : FR < 10/min
Durée d'action et demi-vie courte 20 à 30 min (plus brève que les morphiniques) => surveillance rapprochée pour éviter une "remorphinisation" secondaire (effet rebond)

PRÉPARATION :

Prélever une ampoule et compléter à 10 mL avec du NaCl 0,9%
Concentration 0,04 mg/mL



POSOLOGIE :

0,01 mg/kg soit 0,25 mL/kg

Poids (kg)	Dose (mg)	Volume à injecter (mL)
3	0,03	0,8
4	0,04	1
5	0,05	1,3
6	0,06	1,5
7	0,07	1,8
8	0,08	2
10	0,1	2,5
12	0,12	3
15	0,15	3,5
17	0,17	4,3
20	0,2	5
25	0,25	6,3
30	0,3	7,5
35	0,35	8,8
≥ 40	0,4	10

EFFETS SECONDAIRES :

- Tachycardie, HTA à fortes doses
- Agitation, anxiété, frissons, vomissements
- Syndrome de sevrage chez les usagers chroniques d'opioïdes

INTRA NASAL

NALOXONE - NARCAN®
Ampoule de 0,4 mg/1 mL

Antagonistes des morphiniques

PLUSIEURS INDICATIONS : UNE FICHE PAR INDICATION

INDICATIONS :

- Surdosage aux opiacés : traitement de la dépression respiratoire (FR< 10)
  Voie intranasale à privilégier en absence de VVP disponible immédiatement

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité connue à la Naloxone ou aux morphiniques

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Arrêter les opioïdes en cours, stimuler le patient, débuter Oxygène si SpO_2 < 90 % et/ou FR entre 8 à 10
Durée d'action et demi-vie courte 20 à 30 min (plus brève que les morphiniques) => surveillance rapprochée pour éviter une "remorphinisation" secondaire (effet rebond)
Cf. fiche intra-nasal p.25

PRÉPARATION :

Avec une seringue de 1 mL, prélever une ampoule PURE (0,4 mg/ 1 mL)
Connecter l'embout nasal spécifique MAD

POIDS < 20 kg : préparer une seringue



POIDS ≥ 20 kg : préparer deux seringues a administrer dans chaque narine



POSOLOGIE :

POIDS < 20 kg : une ampoule pure dans une narine

POIDS ≥ 20 kg : une ampoule pure dans CHAQUE narine

Ne pas administrer plus de 1 mL par narine

EFFETS SECONDAIRES :

- Tachycardie, HTA à fortes doses
- Agitation, anxiété
- Vomissements
- Syndrome de sevrage chez les usagers chroniques d'opioïdes

NORADRENALINE - NORADRENALINE®

Ampoule de 8 mg/4 mL
Concentration : 2 mg/mL

Amines, vasoconstricteur artériel

INDICATIONS :

– État de choc chez le traumatisé sévère

CONTRE-INDICATIONS :

– Aucune en situation d'urgence

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :



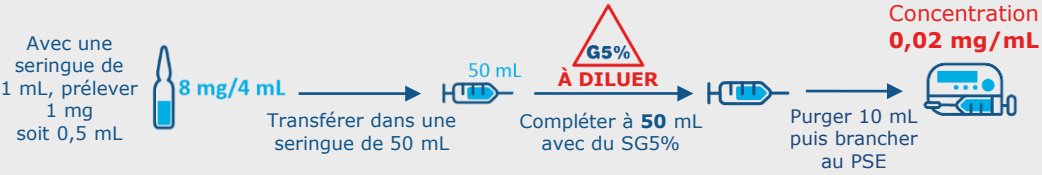


Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
VVP dédiée ; PAS de bolus
Privilégier une VVP de gros calibre pour le remplissage et une 2ème VVP pour la noradrénaline
UTILISER TOUJOURS UN KT BILUMIERE pour une injection au plus près du patient
Pas de prolongateur ; robinet au plus près

PRÉPARATION : À DILUER

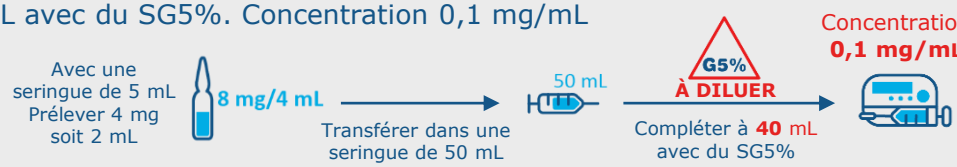
- POIDS < 30 kg :

Avec une seringue de 1 mL, prélever 1 mg soit 0,5 mL et transférer dans une seringue de 50 mL puis compléter à 50 mL avec du SG5%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume au PSE. Purger le prolongateur



- POIDS > 30 kg :

Cf. livret adulte : avec une seringue de 5 mL, prélever 4 mg soit 2 mL de l'ampoule puis transférer dans une seringue de 50 mL, puis compléter à 40 mL avec du SG5%. Concentration 0,1 mg/mL



POSOLOGIE :

Débuter vitesse = (poids/3) mL/h = 0,1 µg/kg/min (soit 6 µg/kg/h) puis augmenter progressivement par palier de 0,1 µg/kg en fonction de l'objectif de PAM/PAS et de la situation clinique toutes les 3 min

TABLEAU DES POSOLOGIES : FICHE SUIVANTE

EFFETS SECONDAIRES :

– Nécrose du point de ponction en cas d'extravasation
– Anxiété, gêne respiratoire, céphalées, tremblements
– Douleur rétrosternale ou pharyngée, photophobie, pâleur, sudation, vomissements, tachycardie, bradycardie



VITESSES DE PSE EN FONCTION DES POSOLOGIES

Débuter avec vitesse = (poids/3) en mL/h = 0,1 µg/kg/min
(soit 6 µg/kg/h) puis augmenter progressivement par palier de 0,1 µg/kg toutes les 3 min en fonction de l'objectif de PAM/PAS

Poids < 30 kg : 1 mg dans 50 mL de SG5%
soit concentration : 0,02 mg/mL
Avec une seringue de 1 mL, prélever 1 mg soit 0,5 mL et transférer dans une seringue de 50 mL puis compléter à 50 mL avec du SG5%. Puis éliminer 10 mL pour ajuster le volume au PSE. Purger le prolongateur

Poids (kg)	0,1 µg/kg/min **soit 6 µg/kg/h**	0,3 µg/kg/min **soit 18 µg/kg/h**	0,5 µg/kg/min **soit 30 µg/kg/h**	1 µg/kg/min **soit 60 µg/kg/h**
3	0,9	2,7	4,5	9
4	1,2	3,6	6	12
5	1,5	4,5	7,5	15
6	1,8	5,4	9	18
7	2,1	6,3	10,5	21
8	2,4	7,2	12	24
10	3	9	15	30
11	3,3	9,9	16	33
12	3,6	10,8	17	36
15	4,5	13,5	22	45
17	5,1	15,3	25	51
20	6	18	30	60
25	7,5	22,5	37	75

Poids > 30 kg : Dilution adulte : 4 mg dans 40 mL de SG5%
Soit concentration : 0,1 mg/mL
Avec une seringue de 5 mL, prélever 4 mg soit 2 mL de l'ampoule puis transférer dans une seringue de 50 mL, puis compléter à 40 mL avec du SG5%

30	1,8	5,4	9	18
35	2,1	6,3	10,5	21
40	2,4	7,2	12	24
50	3	9	15	30

AÉROSOL

SALBUTAMOL – VENTOLINE®
solution pour inhalation 2,5 mg/2,5 mL

β2 mimétique

INDICATIONS :

- Asthme

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité aux produits
- Insuffisance respiratoire décompensée
- Insuffisance hépato cellulaire sévère

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope
Surveillance SpO_2, FR
Matériel de réanimation à proximité
Surveillance glycémie, kaliémie si aérosols répétés

PRÉPARATION : en nébulisation

Vider une dosette dans le nébulisateur
PURE



Sous O_2
Débit : 6 à 8 L/min
Durée d'un aérosol : 10 à 20 min

POSOLOGIE :

Dosettes pour nébulisations prêtes à l'emploi (pas de dilution) :

PUR si association à l'Ipratropium

A DILUER si seul : compléter à 5 mL avec du NaCl 0,9%

Poids < 20 kg : une dosette de **2,5 mg/2,5 mL**

Poids ≥ 20 kg : une dosette de **5 mg/2,5 mL** (adulte)

En association avec l'Ipratropium - Atrovent® pour le premier aérosol
Puis salbutamol seul dans les aérosols suivants

À renouveler toutes les 20 à 30 min, soit 4 nébulisations dans l'heure

EFFETS SECONDAIRES :

- Tremblements, tachycardie
- Hypokaliémie, céphalées, palpitations, crampes musculaires, modification de la glycémie
- Acidose lactique réversible si diminution des doses

SÉRUM SALÉ HYPERTONIQUE 3%
(solution à reconstituer)

Soluté hypertonique

INDICATIONS :

Traumatisme crânien grave avec :
- Anisocorie/mydriase avec pupilles aréactives
- Ou si Triade de Cushing : bradycardie, HTA, respiration irrégulière

CONTRE-INDICATIONS :

- Hyper osmolarité pré existante
- Insuffisance cardiaque
- Déshydratation intracellulaire

INSTALLATION ET SURVEILLANCE :

Scope, monitoring complet du patient
Matériel de réanimation prêt à l'emploi
Surveillance neurologique pupilles

PRÉPARATION : À RECONSTITUER

ATTENTION à la concentration des ampoules (préparer des kits)

Le sérum salé hypertonique n'est pas disponible en prêt à l'emploi, il faut le reconstituer : Mélange à utiliser immédiatement

Dans une poche de 100 mL de NaCl 0,9%, injecter une ampoule de 10 mL de NaCl 20% = On obtient une poche de 110 mL de NaCl 2,6%

Selon le poids, préparer deux poches

100 mL NaCl 0,9 % + NaCl 20%/ 10 mL → **110 mL Concentration à 2,6%** **EN IVDL sur 5 - 10 min**

POSOLOGIE :

3 mL/kg = posologie minimale ; possibilité de monter à 5 mL/kg

Poids < 10 kg : 3 mL/kg à administrer à la seringue sur 5 à 10 min
Poids entre 10 et 17 kg : une demi-poche en IVL sur 10 min
Poids entre 18 et 40 kg : une poche de 110 mL en IVL sur 10 min
Poids entre 41 et 50 kg : une poche et demie en IVL sur 10 min

EFFETS SECONDAIRES :

- Confusion, déshydratation
- Nausées, vomissements, céphalées, vertiges, tachycardie, douleur thoracique
- Hypo ou hypertension
- Insuffisance rénale aiguë